

下面按你的定位（非 PHI、面向家庭教育 + 为 MCO/Trillium 可对接）给你 三件套的“可交付版本”：

SOP（标准流程）+ 试点流程 + 样本材料。可直接用于内部、网站、或发给合作方预览。

一、FASD 家庭常见关切 SOP（标准操作流程）

目的（Purpose）

为 FASD 家庭提供非医疗、非 PHI 的结构化教育与支持，提升家庭理解、稳定照护、减少危机与不必要急诊/住院。

适用范围（Scope）

- 家长/照护者教育
- 学校/社区沟通支持
- 行为理解与环境调整
- 不包含：诊断、处方、个案医疗决策

核心关切模块（Core Concerns）

1. “为什么孩子这样？”（脑发育 vs 行为问题）
2. 行为爆发与失控（meltdown ≠ 故意）
3. 学校问题（被误解为 ADHD/ODD）
4. 执行功能差（记忆、时间、过渡）
5. 家庭压力与照护者疲惫
6. 未来焦虑（青春期、独立性）

标准回应流程（SOP Steps）

1. 识别关切类别（用标准问题清单）
2. 提供对应教育模块（视频 / 图文 / 讲义）
3. 给出 1-2 个可执行策略（环境而非孩子）

4. 提供“下一步资源路径”（学校/社区/支持组）
5. 记录参与情况（非 PHI 指标）

输出（Deliverables）

- 家庭教育包（PDF/视频）
 - 家长行动清单（1 页）
 - 参与完成证明（for MCO / grant）
-

二、NeighborBridge 教育试点流程（Pilot Workflow）

试点目标

- 验证：家庭是否愿意用、是否有感
- 生成：MCO 可理解的过程指标与结果指标

试点周期

👉 4-6 周（低风险、低承诺）

试点流程（Step-by-step）

Step 1 | 家庭招募

- 来源：FQHC 转介 / NCFASD Informed / 社区
- 条件：自我识别为 FASD/疑似家庭

Step 2 | 入门教育（Week 1）

- 模块 1：什么是 FASD（30 分钟）
- 模块 2：行为的“脑机制”解释

Step 3 | 策略应用（Week 2–4）

- 环境调整
- 预期管理
- 沟通方式改变
- 学校沟通模板

Step 4 | 反馈与巩固（Week 5–6）

- 家长自评变化
- 压力变化
- “最有用的 1 件事”

Step 5 | 总结报告（非 PHI）

- 参与人数
- 完成率
- 家庭主观改善指标

三、样本材料（可直接用）

样本 1 | 家长教育摘要（节选）

标题：你的孩子不是“不听话”，而是“大脑不一样”

- FASD 是脑发育差异
- 行为是信息，不是态度
- 改环境比改孩子更有效

- 稳定 > 奖惩

👉 本周只做一件事：

提前预告 + 减少语言 + 给视觉提示

样本 2 | 家长自评问卷（非 PHI）

（0–10 分）

- 我理解孩子行为的原因
- 我对每天的冲突感到无助
- 我知道下一步该向谁求助

（用于前后对比）

样本 3 | MCO 可读的一页摘要（Draft）

NeighborBridge FASD Family Education Pilot

- 服务类型：非医疗家庭教育
 - 目标：减少家庭危机、提升照护稳定性
 - 指标：
 - 参与率
 - 完成率
 - 家长理解度变化
 - 主观压力变化
 - 合规：不接触 PHI，不替代医疗服务
-

给你一个

硬真相（战略提醒）

Trillium / MCO 要的不是“你多专业”，而是：
你能不能稳定交付、低风险、可复制、可计量。

本周挑战（Direct Challenge）

👉 在 7 天内完成：

1. 1 页《FASD 家庭教育模块清单》
2. 1 页《试点流程图》
3. 1 份《家长前后自评问卷（5 题以内）》

如果你愿意，下一步我可以：

- 把这些整理成 Word / PDF
- 或直接帮你写 Trillium 用的一页 proposal